BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CHĂM SÓC CHẢY MÁU MŨI

Mã đề xuất CS-TMH-01; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

ICD: R04.0

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

- Khai thác tiền sử: Bệnh có tiền sử chảy máu mũi và bệnh nội khoa không ?có bị chấn thương , va chạm hay té trúng vùng mũi không?có nhét dị vật vào mũi không?có bị sốt hay đang mắc các bệnh nhiễm trùng nào không? Có bị khối U hốc mũi hay vùng xoang không? Có bất thường giải phẫu vùng mũi xoang không

- Từ lúc bắt đầu chảy đến nay được mấy lần , số lượng máu mất mỗi lần chảy là bao nhiêu ?

- Bệnh lý đã điều trị là các bệnh nào ? tình trạng hiện tại của bệnh mắc phải như thế nào?

- Tiền sử bệnh: Người bệnh đã bị bao lâu rồi, có điều trị không có tiền sử dị ứng hay bệnh lý nào không

- Khám: Quan sát thể trạng, Quan sát da niêm, Quan sát tình trạng hô hấp, xem có vùng vết thương sang chấn vùng mũi không

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1. Nguy cơ choáng do mất máu

2.2. Nguy cơ suy hô hấp do máu chảy vào đường thở

2.3. Người bệnh thiếu kiến thức về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

3.1. Giảm nguy cơ choáng

3.2. Giảm nguy cơ suy hô hấp

3.3. Cung cấp kiến thức cho người bệnh

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Giảm nguy cơ choáng

Đánh giá ABCDE, sinh hiệu, tri giác, lượng máu và dấu hiệu giảm tưới máu; báo bác sĩ khi bất thường. Huyết áp tăng cần đánh giá nguyên nhân và thuốc theo y lệnh, không mặc định hạ áp ngay hoặc quá nhanh.

Chuẩn bị đường truyền, xét nghiệm/dịch/thuốc theo chỉ định khi mất máu hoặc nguy cơ. Oxy theo tình trạng và mục tiêu y lệnh; không thay xử trí đường thở/cầm máu.

- Chuẩn bị dụng cụ nội soi cầm máu

Hỗ trợ bác sĩ đánh giá và cầm máu/khâu khi có chỉ định; điều dưỡng không tự khâu mọi vết thương.

4.2. Giảm nguy cơ suy hô hấp

Người tỉnh và huyết động cho phép: ngồi, cúi nhẹ về trước, nhổ máu ra ngoài; không ngửa đầu. Nếu không ngồi được, bố trí tư thế bảo vệ đường thở theo tình trạng, tránh sặc.

- Nếu người bệnh khó thở cho thở oxy

- Theo dõi nhịp thở để phát hiện tình trạng suy hô hấp để xử true kịp thời

4.3. Cung cấp kiến thức cho người bệnh

- Cho người bệnh nằm nghiêng 1 bên khi có máu chảy nếu người bệnh không ngồi được

Ép liên tục phần mềm cả hai cánh mũi theo hướng dẫn cầm máu, không ép sống mũi; đánh giá đáp ứng và báo bác sĩ nếu còn chảy nhiều. Không nhả liên tục để kiểm tra.

Không tự ngoáy, xì mũi mạnh hoặc rút vật liệu nhét mũi; bác sĩ quyết định can thiệp khi cầm máu ban đầu không hiệu quả.

- Không tự ngoáy mũi làm bông cục máu đông

5. Đánh giá

- Bệnh hết chảy máu

- Bệnh khỏe hơn

- Bệnh ăn uống khá

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám

cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.entnet.org/quality-practice/quality-products/clinical-practice-guidelines/nosebleed-epistaxis/. Áp dụng theo đối tượng và hoàn cảnh của hướng dẫn, không thay thế chỉ định bác sĩ hoặc quy định của bệnh viện.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……